

Tuyến tiền liệt phì đại (BPH)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Tại sao triệu chứng tiểu tiện xảy ra và cách điều trị

Tuyến tiền liệt phì đại — hay tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (BPH) — là tình trạng phổ biến, tuyến tiền liệt lớn dần theo tuổi nhưng **không phải** ung thư. Tuyến phì đại chèn ép niệu đạo và gây ra các triệu chứng tiểu tiện khó chịu. BPH **không** phải ung thư và **không** gây ra ung thư. Có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả, từ thay đổi lối sống đến thuốc và phẫu thuật.

Về tình trạng này

Tuyến tiền liệt bao quanh phần trên của niệu đạo. Khi tuyến phì đại, nó siết chặt đường tiểu, gây ra **các triệu chứng đường tiết niệu dưới (LUTS)**:

- Dòng tiểu yếu hoặc chậm, tiểu khó, phải rặn, dòng tiểu ngắt quãng
- Cảm giác **tiểu không hết** và rò giọt sau khi tiểu
- Tiểu **nhiều lần**, tiểu gấp và thức dậy đi tiểu đêm (tiểu đêm)

Tại sao cần quan tâm

BPH thường ảnh hưởng đến **chất lượng cuộc sống**, nhưng nếu nặng có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiểu, sỏi bàng quang, bí tiểu hoặc hiếm hơn là gây áp lực lên bàng quang và thận. Mức độ khó chịu của bạn quyết định mức độ tích cực của việc điều trị.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

BPH

Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt — tuyến tiền liệt phì đại không phải ung thư.

LUTS

Triệu chứng đường tiết niệu dưới — các vấn đề tiểu tiện do BPH gây ra.

IPSS

Thang điểm triệu chứng để đo mức độ khó chịu.

Bí tiểu

Không thể đi tiểu được — cần cấp cứu ngay.

Alpha blocker / 5-ARI

Hai nhóm thuốc chính điều trị BPH.

PSA

Xét nghiệm máu kiểm tra tuyến tiền liệt, thường được thực hiện trong quá trình đánh giá.

TÔI CÓ BẮT BUỘC PHẢI ĐIỀU TRỊ KHÔNG? Chỉ khi triệu chứng làm phiền bạn — triệu chứng nhẹ có thể theo dõi mà không cần điều trị. Khi triệu chứng ảnh hưởng đến cuộc sống, có thể nâng dần từ thay đổi lối sống lên dùng thuốc rồi can thiệp thủ thuật; mỗi mức đều có lựa chọn hiệu quả. Điều trị cũng phụ thuộc vào kích thước tuyến tiền liệt mà nhóm chăm sóc sẽ đánh giá.

Đánh giá như thế nào

- **Thang điểm triệu chứng (IPSS)** và xem xét lượng nước uống và các thuốc đang dùng
- Khám tuyến tiền liệt, **xét nghiệm nước tiểu** và thường có **PSA**
- Đo tốc độ dòng tiểu và kiểm tra khả năng làm rỗng bàng quang

Điều trị như thế nào (từng bước)

- 1 **Theo dõi & thay đổi lối sống** — giảm uống nước vào buổi tối, hạn chế caffeine/rượu bia, điều chỉnh thói quen đi tiểu.
- 2 **Thuốc — alpha blocker** (giảm triệu chứng nhanh), **thuốc ức chế 5-alpha-reductase** (thu nhỏ tuyến lớn hơn), hoặc kết hợp cả hai; đôi khi dùng thêm thuốc khác.
- 3 **Can thiệp ít xâm lấn** — như nâng niệu đạo tuyến tiền liệt hoặc liệu pháp hơi nước.
- 4 **Phẫu thuật** — TURP, HoLEP, Aquablation hoặc cắt tuyến tiền liệt đơn giản cho tuyến lớn hoặc khi các bước trên không đủ. Mỗi phương pháp có tờ thông tin riêng.

Điều cần biết

- Điều trị BPH dựa trên mức độ **khó chịu của bạn** — không cần vội trừ khi có biến chứng.
- Một số thuốc cảm/dị ứng (thuốc thông mũi) có thể làm nặng thêm triệu chứng.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Bạn **đột ngột không tiểu được** (bàng quang căng đau) — cần xử lý ngay
- **Tiểu ra máu**, sốt hoặc nhiễm trùng tái diễn
- Triệu chứng nặng hơn dù đã điều trị

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. BPH là tình trạng tuyến tiền liệt phì đại lành tính, phổ biến, gây ra triệu chứng tiểu khó và tiểu nhiều lần.
2. Điều trị dựa trên mức độ khó chịu — bắt đầu từ lối sống, rồi đến thuốc, sau đó là can thiệp ít xâm lấn hoặc phẫu thuật.
3. Đến cơ sở y tế ngay nếu đột ngột không tiểu được, hoặc có tiểu ra máu, sốt hoặc nhiễm trùng tái diễn.